

PROTOCOLO DE DOLOR TORÁCICO SUGESTIVO DE ORIGEN CORONARIO EN UNIDAD DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS

Los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias aquejados de dolor torácico pueden categorizarse en varios grupos cuya aproximación diagnóstica y terapéutica es diferente. Esta clasificación previa se hace de modo habitual, sobre la base de los datos clínicos principalmente y la ayuda de exploraciones complementarias sencillas que pueden realizarse desde el Servicio de Urgencias (ECG, Rx tórax y determinaciones de troponina).

Los pacientes objeto de este protocolo son aquellos de riesgo intermedio de presentar una enfermedad coronaria, ya que los que presentan un riesgo alto serán ingresados directamente para estudio. Si el ECG y los niveles de TnI no sugieren isquemia miocárdica el paciente se incluirá en el Protocolo de Dolor Torácico. El paciente será atendido por un Cardiólogo que volverá a realizar una evaluación de su caso.

1. OBJETIVO

Establecer un circuito estandarizado para la evaluación, monitorización, estratificación del riesgo y decisión clínica de los pacientes que consultan por dolor torácico sugestivo de origen coronario y requieren un periodo de observación clínica desde Urgencias.

Los objetivos específicos son:

- Identificar de forma precoz el **síndrome coronario agudo (SCA)** y otras causas potencialmente letales.
- Evitar ingresos hospitalarios innecesarios mediante observación protocolizada.
- Mejorar seguridad clínica reduciendo altas inapropiadas.
- Disminuir tiempos de estancia y optimizar utilización de camas hospitalarias.
- Homogeneizar criterios diagnósticos y terapéuticos entre facultativos.

2. DEFINICIÓN DE PACIENTE CANDIDATO A UNIDAD DE OBSERVACIÓN

Con los datos aportados por estas dos pruebas complementarias (ECG y Tn I us) junto con los datos clínicos, se podrá definir si el paciente está sufriendo un IAM, y en caso negativo el riesgo de que sufra un evento cardiovascular grave en los próximos 30 días.

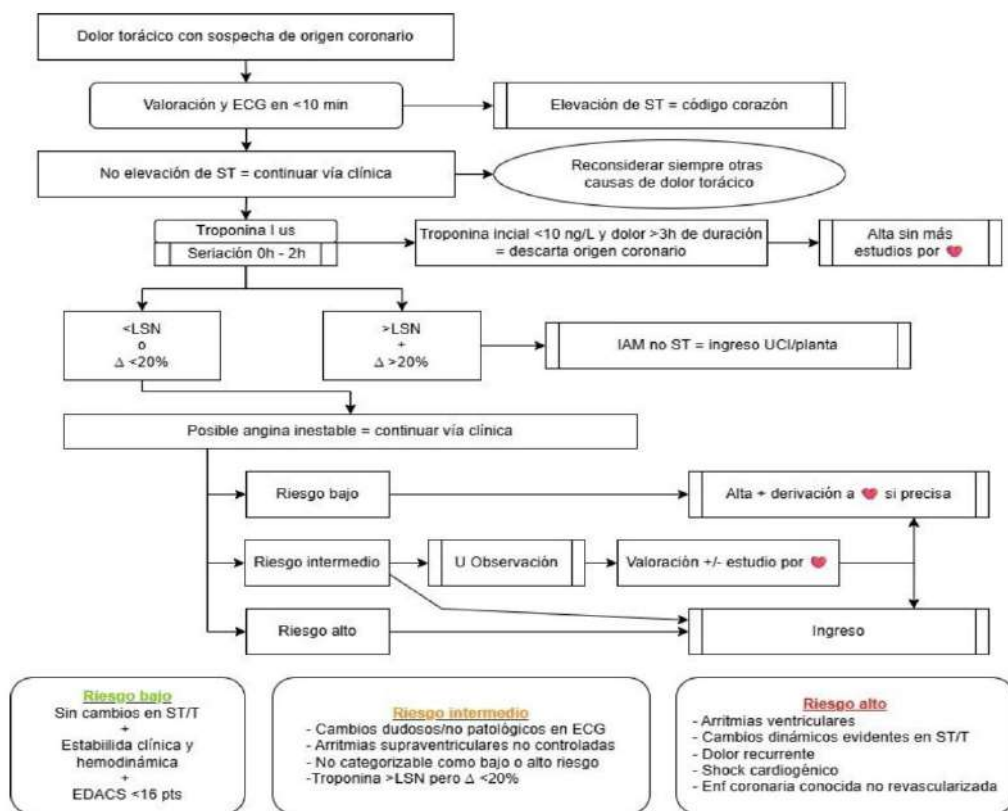
El paciente de riesgo bajo podrá ser dado de alta con seguridad desde urgencias. El de riesgo intermedio se beneficiará de ingreso en la Unidad de Observación. Y el de alto riesgo por lo general va a requerir ingreso en UCI o planta de hospitalización.

Probabilidad de isquemia

Central	Izquierdo	Derecho
Localización vaga		Localizado a punta de dedo
Opresión/Peso Agarre	Insidioso/sordo > urente/desgarrador	Punzante
Relacionado con estrés/esfuerzos (puede ocurrir en reposo en SCA)		Relacionado con postura y respiración
<1h de duración, inicio no súbito	Horas de duración	Fugaz
Síntomas acompañantes (náuseas, mareo, disnea, <u>presíncope</u> , palpitaciones). Más frecuente en ♀, diabéticos y ancianos.		

Para determinar que un paciente es de bajo riesgo, además de tener ECG sin cambios sugestivos de isquemia y seriación de troponina ultrasensible negativa, es muy útil y recomendable usar herramientas de apoyo a la decisión clínica.

Se recomienda estandarizar el uso del score EDACS, por su altísimo valor predictivo negativo para descartar MACE los 30 días.



Paciente con **dolor torácico o equivalente anginoso** que, tras valoración inicial en Urgencias, **no presenta criterios inmediatos de ingreso ni de alta segura**, y requiere monitorización, seriación analítica o reevaluación clínica.

Ejemplos:

- Dolor torácico sugestivo pero no diagnóstico de SCA.
- Dos Troponinas iniciales negativas con necesidad de seriación.
- ECG no diagnóstico.
- Duda diagnóstica entre origen cardiológico y no cardiológico.
- Necesidad de observación tras control sintomático.

3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DESDE URGENCIAS A LA UNIDAD DE OBSERVACIÓN

Se aceptarán pacientes que cumplan **TODOS** los siguientes criterios:

A. Estabilidad clínica

- TA sistólica ≥ 90 mmHg sin soporte vasoactivo.
- FC 50–110 lpm.
- Saturación $\geq 92\%$ (o basal conocida).
- Sin deterioro del nivel de conciencia.
- Ausencia de insuficiencia respiratoria aguda.

B. Riesgo cardiovascular intermedio

Características compatibles con:

Riesgo intermedio

- Sospecha moderada de SCA sin criterios de alto riesgo.
- Antecedentes cardiovasculares que requieran observación.
- Necesidad de completar protocolo seriado.

Herramientas orientativas:

- **EDACS bajo/intermedio (ANEXO I)**
- Escalas como apoyo, nunca sustituyen juicio clínico.

C. Situaciones clínicas frecuentes admitidas

- Sospecha de angina estable sin criterios de alto riesgo.
- Sospecha de pericarditis / miopericarditis estable.
- Seguimiento postcontrol de crisis hipertensiva asociada.

4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN / INGRESO DIRECTO HOSPITALARIO

Cualquier criterio siguiente excluye ingreso en Unidad de Observación:

A. Síndrome coronario agudo confirmado o altamente probable

- Elevación persistente del ST.
- Equivalentes de SCACEST.
- Troponina positiva con dinámica compatible.
- Cambios dinámicos en ECG.

→ Activación circuito cardiológico.

B. Inestabilidad hemodinámica

- Hipotensión persistente.
- Shock.
- Arritmias significativas.
- Necesidad de drogas vasoactivas.

C. Criterios de ingreso en pacientes con Angina estable.

- Síntomas de Insuficiencia cardíaca o hipotensión acompañantes.
- Angina clase III o mayor, reciente, particularmente con mala respuesta al tratamiento.
- Pacientes con revascularización coronaria y recurrencia precoz de angina clase II o III
- Ergometría de mal pronóstico conocida.
- Secundaria a arritmia ventricular, bloqueo AV u otra causa que requiera ingreso.

D. Sospecha de diagnóstico tiempo-dependiente

- Disección aórtica.
- Tromboembolismo pulmonar de riesgo intermedio–alto o alto.
- Taponamiento cardíaco.
- Neumotórax significativo.
- Rotura esofágica.

E. Complicaciones asociadas

- Insuficiencia cardiaca aguda.
- Edema agudo de pulmón.
- Dolor recurrente refractario.
- Hipoxemia mantenida.
- Síncope de probable origen cardiaco.

F. Situaciones organizativas

- Necesidad previsible de estancia >36 h.
- Necesidad de procedimiento invasivo urgente.
- Dependencia funcional que requiera hospitalización convencional.

Los pacientes con alguna de estas condiciones y que no hayan sido descartados para revascularización coronaria serán ingresados en una planta de hospitalización de Cardiología o Medicina Interna.

5. EVALUACIÓN INICIAL EN LA UNIDAD DE OBSERVACIÓN

Debe realizarse dentro de la primera hora.

A. Revaloración clínica

Registrar:

- Características del dolor (OPQRST).
- Factores desencadenantes.
- Equivalentes anginosos.
- Antecedentes cardiovasculares.
- Factores de riesgo cardiovascular.
- Medicación habitual.

B. Exploración física dirigida

- Constantes completas.
- Auscultación cardiopulmonar.
- Pulsos periféricos.
- Signos de insuficiencia cardiaca.
- Exploración vascular.

C. Monitorización

- ECG continuo (si sospecha cardiológica).
- SatO₂.
- TA seriada.

D. Estudios complementarios

ECG

- ECG inicial ya realizado en Urgencias.
- Repetición:
 - ante recurrencia del dolor;
 - cada 2–4 h si sospecha intermedia;
 - previo al alta.

Biomarcadores

Protocolo recomendado con **troponina ultrasensible**:

Tras los dos resultados iniciales: **0–2 h**, siendo normales, pasará a la Unidad de Observación donde se realizará repetición a las **4-6 horas**.

Registrar:

- valor absoluto;

E. Ecografía clínica (POCUS) — recomendable

Valoración orientada según sospecha:

Cardiaca:

- Función VI global.
- Alteraciones segmentarias groseras.
- Derrame pericárdico.
- Signos indirectos de sobrecarga derecha.

Pulmonar:

- Neumotórax.
- Síndrome intersticial.
- Derrame pleural.

Aórtica:

- Aorta proximal si experiencia disponible.
- (La ecografía no sustituye estudios definitivos).

6. CONTROL EVOLUTIVO EN UNIDAD DE OBSERVACIÓN

Reevaluación médica protocolizada

Cada 2–4 horas

Registrar:

- Persistencia o recurrencia del dolor.
- Constantes.
- ECG si cambios clínicos.
- Respuesta terapéutica.

Tratamiento

Individualizado según sospecha:

Sospecha coronaria

- Antiagregación si indicada.
- Control antianginoso.
- Evitar sobremedicación en pacientes de bajo riesgo.

Dolor no coronario

- Analgesia escalonada.
- Tratamiento etiológico.

Indicadores de empeoramiento

Requieren reevaluación inmediata:

- Recurrencia del dolor típico.
- Elevación de troponina.
- Nuevos cambios ECG.
- Arritmias.
- Inestabilidad clínica.

7. CRITERIOS DE DESTINO AL ALTA DESDE LA UNIDAD DE OBSERVACIÓN

A. Alta domiciliaria

Todos los siguientes:

- Asintomático $\geq 4-6$ horas.
- Estabilidad hemodinámica.
- ECG sin cambios dinámicos.
- Troponinas negativas según protocolo.
- Sin datos clínicos de enfermedad tiempo-dependiente.
- Reevaluación médica favorable.
- Valoración y contestación de la Interconsulta por parte de Cardiología.

Informe de alta incluirá:

- Diagnóstico probable.
- Interconsulta contestada por parte de Cardiología.
- Signos de alarma.
- Tratamiento.
- Seguimiento.

Seguimiento preferente:

- Atención Primaria.
- Consulta de alta resolución / cardiología según disponibilidad.

B. Ingreso hospitalario

Indicado si aparece:

- Dolor recurrente.
- Troponina positiva.
- Cambios ECG.
- Diagnóstico alternativo que precise ingreso.
- Necesidad de estudio avanzado.

Destino:

- Cardiología.
- Medicina Interna.
- Unidad coronaria.
- Especialidad correspondiente.

8. INDICADORES DE CALIDAD PROPUESTOS (adaptables a SEMES)

Indicadores de gestión

- Tiempo puerta–ECG <10 minutos.
- Tiempo puerta–troponina inicial <30 minutos.
- Estancia media en UO.
- % altas desde UO.

Indicadores de calidad asistencial

- Reconsulta a 72 h por dolor torácico.
- Eventos cardiovasculares mayores a 30 días.
- Ingreso diferido <72 h.
- Adecuación de indicación de ingreso en UO.
- Cumplimiento del protocolo ECG–troponinas.

ESTUDIO POR PARTE DE CARDIOLOGÍA DESDE UNIDAD DE OBSERVACIÓN

Los pacientes de riesgo intermedio que permanezcan unas horas en observación serán valorados por cardiología en las primeras horas del próximo día laborable para decidir si el paciente precisa ingreso, puede ser alta o se beneficiaría de realizar una prueba de detección de isquemia durante la mañana. Igualmente podrían requerir la realización de un ecocardiograma.

Las pruebas de detección de isquemia disponibles en nuestro centro y sus indicaciones son las siguientes:

- Ergometría convencional. Limitado a pacientes con ECG basal normal y capacidad de caminar/correr en cinta. Sensibilidad 58-73%, especificidad 60-80%.
- Ecocardiograma de estrés. Limitado a pacientes con aceptable ventana ecoica y capacidad de caminar/correr en cinta. Sensibilidad 80-88%, especificidad 80-95%.

Referencias:

Six AJ, Backus BE, Kelder JC.: *Chest pain in the emergency room: value of the HEART Score*. Neth Heart J 2008; 16: 191-196

Mahler SA, Hiestand BC, Goff DC, et al.: *Can the HEART Score safely reduce stress testing and cardiac imaging in patients at low risk for major adverse cardiac events?*. Crit Pathways in Cardiol 2011; 10: 128-133

ANEXO I

EDACS — ED Assessment of Chest Pain Score

Identifica pacientes con dolor torácico en urgencias de **muy bajo riesgo** de SCA para alta temprana. Score < 16 + ECG y troponina normal = alta.

RESULTADO EDACS 0/6 ÍTEMS

—/50

Sin calcular

Suma edad/sexo + factores de riesgo + características del dolor.

1. Edad

- +2 18 – 45 años
- +4 46 – 50 años
- +6 51 – 55 años
- +8 56 – 60 años
- +10 61 – 65 años
- +12 66 – 70 años
- +14 71 – 75 años
- +16 76 – 80 años
- +18 81 – 85 años
- +20 ≥ 86 años

2. Sexo

- +0 Femenino
- +6 Masculino

3. Factores de riesgo (sólo si edad 18-50 Y [≥3 FR CV O enfermedad CV conocida])

- +0 No aplica (edad > 50, o < 3 FR sin CAD conocida)
- +4 Sí: edad 18-50 Y (≥3 FR CV: HTA, DM, dislipemia, tabaco, AHF; O CAD conocida)

4. Diaforesis (sudoración profusa)

- +0 No
- +3 Sí

5. Dolor irradiado a brazo, hombro, cuello o mandíbula



+0 No

+5 Sí

6. Dolor con la inspiración O reproducible con palpación (reduce probabilidad)

+0 Ninguno

+4 Dolor con inspiración (pleurítico)

+6 Dolor reproducible a la palpación

¿Qué es el EDACS?

El **EDACS** es una regla más reciente (2014) diseñada específicamente para identificar pacientes con dolor torácico de **muy bajo riesgo de SCA** que pueden ser dados de alta temprano. Forma parte del protocolo **EDACS-ADP** (Accelerated Diagnostic Protocol):

- EDACS < 16, Y
- ECG sin isquemia, Y
- Troponina 0 h y 2 h ambas negativas

Cumpliendo los 3, el paciente puede ser dado de alta a las ~ 6 h con riesgo de MACE 30 días < 1%.

Interpretación

Score	Categoría	Conducta
< 16 + ECG normal + Tn 0/2 h normal	Muy bajo riesgo	Alta temprana (< 6 h)
≥ 16 O ECG isquémico O Tn elevada	No bajo riesgo	Continuar evaluación / observación